

Monika Krohwinkel

Pflegemodelle

Modell: Fördernde Prozesspflege

Pflegerahmenmodell

Strukturmodell (13ABEDL)

Pflegetheorie

Bedürfnistheorien zugeordnet: Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen zu erkennen und folglich Bedürfnisdefizite auszugleichen + Augenmerk auf die Bezugsperson des Pflegeempfängers

Pflegeprozessmodell

(6 Schritte nach Fiechter und Meier)

Informations-
sammlung

Stammdaten

Biografie

Pflegeanamnese
*(13 AEBDL)

Probleme/
Ressourcen

*13 ABEDL

PESR
(Pflegediagnosen)

Assessments/ Exper-
tenstandards

Beratungsgespräche

Ziele

SMART

Maßnahmen

*W-Fragen +
Hilfeformen*

Expertenstand-
ards/Standards

Durchführung

Pflegebericht

Evaluation

Managementmodell

Qualitätsentwicklungsmodell incl.
Modell zum reflektierten
Erfahrungslernen

Pflegetheorien und -modelle

Definition

- **Pflegetheorien** sind **Gedankenkonstrukte** von **Aussagen zur Beschreibung und Erklärung** der Disziplin Pflege oder von Teilen daraus. Sie **definieren**, was **Pflege ist** oder im **Idealfall sein sollte** und **worin sich Pflege von anderen Disziplinen unterscheidet**.

Theorien sind **Hilfsmittel** für die **Analyse und Reflexion der Pflegepraxis** und bieten **Hinweise für adäquates Handeln**. Sie sollen zu einer verantwortungsvoll begründeten Gestaltung der Pflegepraxis beitragen. Dies schließt aus, sie wie fertige Rezepte 1:1 in der Praxis anwenden zu wollen.

- **Pflegemodelle** stellen **Pflegetheorien dar** und haben Einfluss auf die Pflegepraxis.

Um Qualität in der Pflege aufrechtzuerhalten und stetig zu verbessern, bedarf es gut ausgearbeiteten Konzepten und Modellen, welche wiederum auf Pflegetheorien basieren (Icare Pflege: Lauber, 2020, S.116).

Pflegetheorie Monika Krohwinkel

Monika Krohwinkel beschäftigte sich mit der ganzheitlichen Pflege von Apoplexpatienten.

Krohwinkel betont, dass das primäre pflegerische Interesse nicht nur an den **Bedürfnissen** und **Fähigkeiten** des **Pflegebedürftigen** selbst ausgemacht wird, sondern auch an der **mitbetroffenen Bezugsperson** (Icare Pflege: Lauber, 2020, S. 125).

Krohwinkel vs Roper, Logan, Tierney

Beide lassen sich den **Bedürfnistheorien** zuordnen, welche sich im Allgemeinen mit der Kernfrage „**Was tun Pflegende?**“ beschäftigen. Das Augenmerk liegt darauf, **Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen zu erkennen und folglich Bedürfnisdefizite auszugleichen** (Icare Pflege: Lauber, 2020, S. 119).

In beiden Theorien ist der **Pflegeempfänger eine pflegebedürftige Person**. Krohwinkel legt jedoch ein Augenmerk auf die Bezugsperson des Pflegeempfängers und bezieht diese bewusst in den Pflegeprozess und dessen Planung ein (Icare Pflege: Lauber, 2020, S. 125). Die Pflegekraft bildet in beiden Modellen den Pflegenden.

Zum Hintergrundwissen

Pflegetheorie nach Roper, Logan, Tierney

Die Theorie bezieht sich **nicht ausschließlich auf kranke Menschen**, sondern erstreckt sich auf **präventive Maßnahmen** zur **Erhaltung von Gesundheit** und der **Förderung größtmöglicher Selbständigkeit** des einzelnen Patienten.

Roper, Logan, Tierney verstehen Pflege als die Unterstützung eines Menschen, um:

zu **verhindern**, dass **potentielle Probleme** im Zusammenhang mit den Lebensaktivitäten **zu aktuellen Problemen** werden
aktuelle **Probleme** zu **lösen**

nach Möglichkeit jene **Probleme** zu **lindern**, die nicht gelöst werden können

positiv mit solchen Problemen umzugehen, die nicht gelöst oder gelindert werden können

das Wiederauftreten eines gelösten Problems zu verhindern

sich **sowohl** wie möglich zu **fühlen**, möglichst **schmerzfrei** zu leben und die Lebensqualität auch dann noch zu maximieren, wenn der Tod unvermeidlich ist.

Das **Pflegemodell** nach Roper, Logan und Tierney geht von der Gesundheit aus – mit dem Schwerpunkt auf der Individualität menschlicher Lebensaktivitäten.

- Die **12 Lebensaktivitäten** (LAs)
- Die Lebensspanne (*Jede Lebensspanne beeinflusst das Verhalten in den LA / Pflege kann man in jeder Lebensspanne benötigen können*)
- Das Abhängigkeits-/Unabhängigkeits-Kontinuum (*Unterschiedliche Abhängigkeitsgrade*)
- Faktoren, welche die LAs *beeinflussen* (*Biologische, psychologische, soziokulturelle, umgebungsabhängige und wirtschafts-politische Faktoren - Die fünf Faktoren beeinflussen jede einzelne LA und stehen eng mit der Lebensspanne und dem Abhängigkeits-/ Unabhängigkeits-Kontinuum in Verbindung.*)
- **Individualität der Pflege**
Individualität eines Menschen kann sich auf verschiedene Weise äußern:

Wie führt der Mensch eine bestimmte Lebensaktivität aus?

Wie oft? Wo? Wann? Warum? Was weiß der Mensch über die LA? Was glaubt der Mensch über die LA? Welche Überzeugungen und Haltungen hat der Mensch gegenüber der LA?

Die Individualisierung der Pflege erfolgt durch die Umsetzung des Pflegeprozesses.

Modell der fördernde Prozesspflege nach Monika Krohwinkel

Das Rahmenmodell der Fördernden Prozesspflege stammt von Monika Krohwinkel und ist vor allem in der deutschen Altenpflege weitverbreitet. [27] , [28] Im Zusammenhang mit dem ersten von der Bundesrepublik Deutschland vergebenen Pflegeforschungsauftrag untersuchte Krohwinkel **1991 zunächst ihre Vorstellungen von einer ganzheitlich rehabilitierenden Pflege von Apoplexiekranken**. Krohwinkels Erhebungen und Analysen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen erstrecken sich insgesamt über einen Zeitraum von fast 30 Jahren. Sie griff bei der Entwicklung ihres Modells auf vorbestehende Theorien, u. a. von Maslow, Rogers, Peplau und Henderson, zurück und entwickelte zunächst das AEDL®-Modell (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens).

1999 erweitert Krohwinkel die AEDL® um den Aspekt der Beziehungen. Sie spricht nun von Aktivitäten, Beziehungen und existenziellen Erfahrungen des Lebens, ABEDL®. In der praktischen Anwendung werden die **ABEDL®** häufig als Struktur für Pflegeplanungen verwendet.

Die ABEDL® beinhalten:

1. Kommunizieren können

2. Sich bewegen können

3. Vitale Funktionen des Körpers aufrechterhalten können

4. Sich pflegen können

5. Essen und trinken können

6. Ausscheiden können

7. Sich kleiden können

8. Ruhen und schlafen können

9. Sich beschäftigen können

10. Sich als Mann/Frau fühlen können

11. Für Sicherheit in der Umgebung sorgen können

12. Soziale Bereiche des Lebens sichern können

13. Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können

Wichtige

Übergeordnete Bedeutung, da prioritär verursachend
für Probleme in den anderen ABEDL

}

Einfluss auf alle anderen ABEDL

„Ganzheitlich Fördernde Prozesspflege“ Monika Krohwinkel

M. Krohwinkel, die bislang einzige deutsche Pflege-theoretikerin, hat eine Fördernde Prozesspflege als konzeptuelles System entwickelt. Ihr System besteht aus 5 Teil-Konzepten (ABEDL-**Strukturmodell** (Aktivitäten, Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens (ATL's nach Rogers)), **Rahmenmodell**, **Pflegeprozessmodell**, **Managementmodell** und **Modell zum reflektierenden Erfahrungslernen**), wobei ihr Hauptaugenmerk einerseits auf einer allumfassenden Erhebung der Pflegesituation eines Menschen mit seinen **sowohl fördernden** als auch **gefährdenden existentiellen Erfahrungen** liegt, andererseits alle **Pflegehandlungen**, ob eigenständig oder angeordnet, immer **Prozesshaft geplant, durchgeführt und evaluiert werden**. Unter Berücksichtigung der ABEDL „mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen können“, ist es wichtig, die Pflege von einer defizitorientiert-versorgenden Handlung in eine **fähigkeitsorientiert-fördernde** Prozesspflege zu überführen. Deshalb entwickelte sie Kategorien, die helfen, um Pflegehandlungen sichtbarer, ganzheitlicher, kongruenter und kontinuierlicher zu gestalten, damit letztendlich **Unabhängigkeit und Wohlbefinden bei den Pflegenden erzielt werden kann**.

Kernaussage „Fördernde Prozesspflege“

Lebens- und Entwicklungsprozesse, krankheits- und Gesundheitsprozesse, unter Umständen das Leben selbst, hängen ab von den Fähigkeiten und Ressourcen des Menschen, die es ihm ermöglichen:

- > Lebensaktivitäten zu realisieren
- > Soziale Beziehungen und Bereiche zu sichern und zu gestalten
- > mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen und sich dabei entwickeln zu können

Zu Krohwinkels Theorie gehören noch weitere Elemente:

- **Pflegerahmenmodell** zur Definition der Prozesspflege mittels **primären pflegerischen Interessen**, **primärer pflegerischer Zielsetzung** und **primärer pflegerischer Hilfeleistung**
- **Pflegeprozessmodell** als individueller Problemlösungs- und Beziehungsprozess, unterteilt in **vier Schritte**
- **Managementmodell** zur Definition der **Rahmenbedingungen** der Pflege (**zeitlich, personell, strukturell**)
- **Qualitätsentwicklungsmodell**,
- **Modell des reflektierenden Erfahrungslernens (integriert in das Qualitätsentwicklungsmodell)**.

Um Monika Krohwinkels Theorie adäquat anzuwenden, werden alle Aspekte ihres Pflegemodells berücksichtigt.

Pflegerahmenmodell

Primäres pflegerisches Interesse

- **Pflegebedürftige Person und persönliche Bezugsperson**
Fähigkeiten, Probleme, und Bedürfnisse in Aktivitäten des Lebens, in Beziehungen und in existenziellen Erfahrungen des Lebens (ABEDL's®)

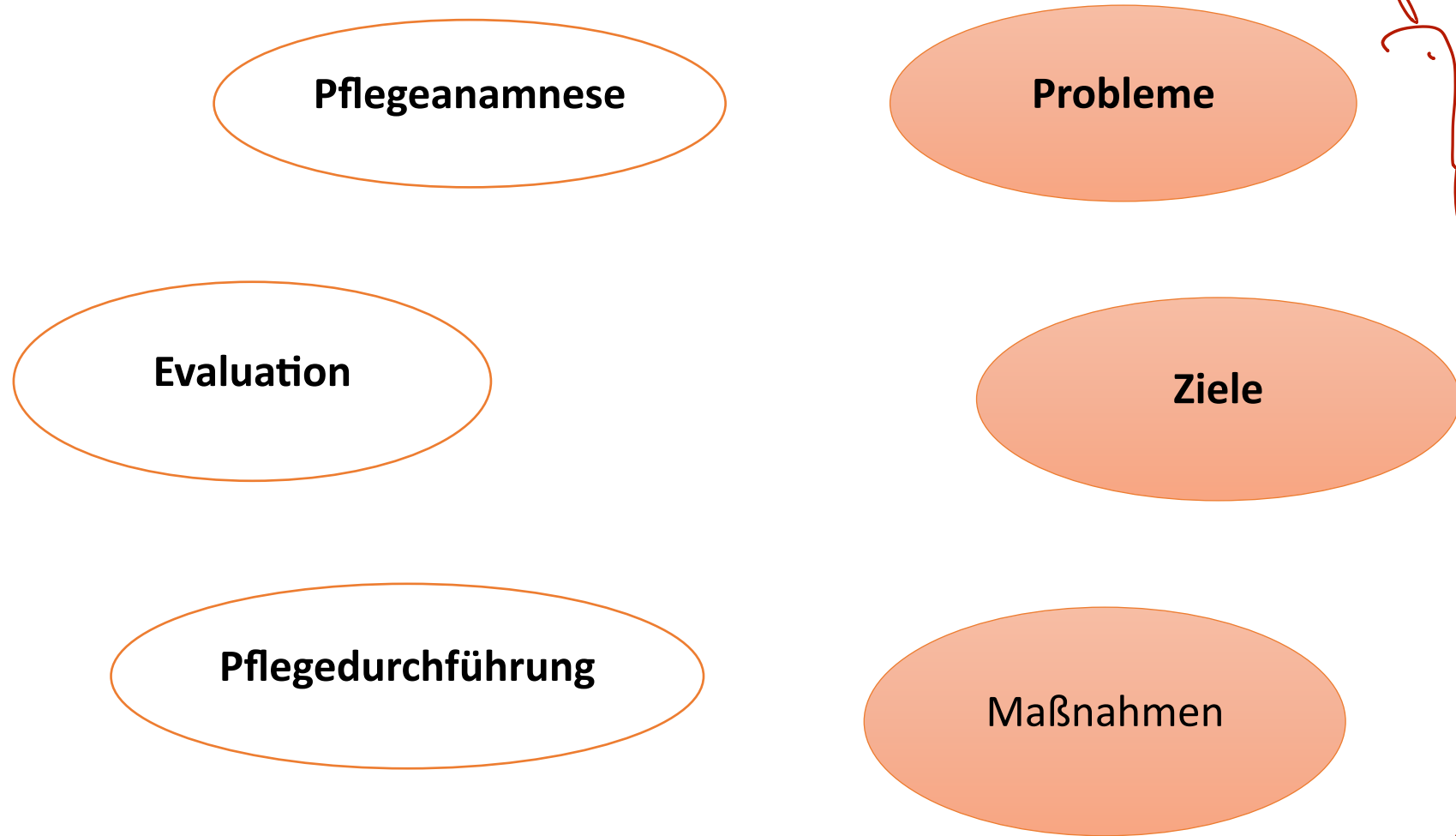
Primäre pflegerische Zielsetzung

- **erhalten, erlangen und wiedererlangen**
von Fähigkeiten und Ressourcen zur Realisierung und Gestaltung von Unabhängigkeit und Wohlbefinden in den ABEDL's®

Primäre pflegerische Handlungen

- **mit den Personen fördernd kommunizieren und**
sie unterstützen, anleiten, beaufsichtigen, informieren, beraten, begleiten und **in ihrem Sinne handeln**

Pflegeprozessmodell



Pflegeplanung

Pflegeprozess: Begriff und Bedeutung

Definition

Pflegeprozess: Fortlaufende Abwägung von Entscheidungen über die Gestaltung der pflegerischen Dienstleistung. Die Pflegefachperson handelt im Idealfall gemeinsam mit dem Patienten, Bewohner oder dessen Angehörigen aus, welche Pflegemaßnahmen nötig und sinnvoll sind.

Prozess (lat. procedere = fortschreiten, vorangehen): Betont in der Pflege den in Schritte unterteilten, definierten und damit überprüfbaren Verlauf der Pflegebeziehung, die sich flexibel an die variablen Bedürfnisse des pflegebedürftigen Menschen anpasst.

Der Pflegeprozess bildet einen strukturierten Rahmen für die Entwicklung der Pflege im Lauf einer Pflegebeziehung. Er dient als detaillierte Handlungsanweisung und wirkt darauf hin, die Maßnahmen immer besser an die Bedürfnisse des Patienten anzupassen, um die gemeinsam erarbeiteten Ziele so gut wie möglich zu erreichen.

Wichtige Eigenschaften des Pflegeprozesses:

- **Dynamik:** Der Pflegeprozess passt sich den Bedürfnissen und Entwicklungen des Pflegebedürftigen an. Veränderte Bedingungen können z. B. durch den Erfolg einer Pflegestrategie oder die Veränderung des Krankheitsbilds verursacht sein. Deshalb ist es nicht sinnvoll, nur einmalig zu Beginn einer Pflegebeziehung (beim Erstkontakt, bei der Aufnahme ins Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung) einen Pflegeplan zu erstellen. Zielgerichtete Pflege benötigt sorgfältige Beobachtung und flexible Reaktion auf den wandelbaren Zustand des pflegebedürftigen Menschen.
- **Disziplinentorientierung:** Der Pflegeprozess klärt ausschließlich pflegerelevante Fragen. Er bildet die spezielle Struktur pflegerischer Arbeit ab, die sich in wesentlichen Punkten von der Aufgabe verwandter Berufsgruppen, z. B. Ärzten, Physiotherapeuten, unterscheidet.

Sinn und Zweck

Erwartungen an die Arbeit mit dem Pflegeprozess sind:

- Individuelle Wünsche des Patienten oder Bewohners sind erfasst und berücksichtigt.
- Bedürfnisse, vorhandene Fähigkeiten sowie und Einschränkungen sind erfasst.
- Die Selbstständigkeit des Patienten oder Bewohners ist optimal unterstützt.
- Die Qualität der Pflege steigt (► 6.5.2).

- Die Pflege erfolgt auf **professionellem Niveau**.
- Die Vermeidung unnötiger Routinearbeiten spart Zeit und Geld.

In stationären Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Pflege hat der Pflegeprozess darüber hinaus folgende Bedeutungen:

- **Umsetzung der Vorschriften des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK)**
- Sachgerechte Begründung der **entstehenden Kosten sowie der Kategorisierung Betroffener in Pflegegrade** (► 4.2)

Im **deutschsprachigen** Raum ist die Einteilung des **Pflegeprozesses** durch die Pflegewissenschaftlerinnen **Verena Fiechter und Martha Maier** **weitverbreitet**. [1] In den USA war Lydia Hall eine der ersten Pflegeetheoretikerinnen, die den Pflegeprozess als Grundlage für die Planung und Auswertung der Pflegearbeit einforderte. [2] Interessant ist die Begründung: Es ging damals, in den 1950er- bis 1980er-Jahren, um die Aufwertung der Pflegearbeit im Vergleich zur Medizin.

Im **seit 2020 geltenden Pflegeberufegesetz (PflBG)** sind „die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs“ für die „Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses“ sowie für „die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege“ als **vorbehaltene Tätigkeit** definiert. Das bedeutet, dass sie nur von dafür ausgebildeten Pflegefachpersonen ausgeführt werden dürfen. [3] Auch in den Rahmenplänen der Fachkommission nach § 53 PflBG ist der Pflegeprozess als berufsspezifische Arbeitsmethode und Grundlage pflegerischen Handelns verankert.

Managementmodell

Mit dem Managementmodell werden die nach Krohwinkels Ansicht notwendigen **Rahmenbedingungen** der Pflege definiert. Dazu gehören **zeitliche, personelle und strukturelle Ressourcen**, die zur Erfüllung der pflegerischen Hauptaufgaben und Verantwortungsbereiche erforderlich sind. Dabei beschreibt sie fünf Tätigkeitsbereiche:

Direkte Pflege:

Konkrete Durchführung der Pflegemaßnahmen

Pflegedokumentation:

Durchführung der pflegerischen Dokumentation innerhalb des Pflegeprozesses

Arbeitsorganisation:

Bedarfsanalyse, Festlegung der Entscheidungs-, Delegations- und Evaluationsverantwortung für die pflegerischen Aufgaben, Methoden und Ressourcen

Diagnostik und Therapie:

Übernahme der Durchführungsverantwortung innerhalb ärztlicher Entscheidungs-, Delegations- und Evaluationsverantwortung

Kooperations- und Koordinationsleistungen:

Aufgaben, die in Abstimmung mit den anderen Berufsgruppen und Arbeitsbereichen von der Pflege wahrgenommen werden

Das Qualitätsentwicklungsmodell

Im Qualitätsentwicklungsmodell nach Krohwinkel wird Qualitätsentwicklung in **zyklischen, miteinander verbundenen Prozessen** dargestellt. Qualitätsentwicklung nimmt im Wesentlichen natürlich den Pflegeprozess und die konkreten Aufgaben- und Verantwortungsbereiche in den Blick, ohne dabei andere Bereiche (z. B. Mitarbeit bei medizinischer Diagnostik und Therapie) auszublenden. Dabei geht es einerseits um **fachliche Qualitäten**, wie z. B. die Pflegebedarfserhebung und Pflege-Maßnahmenplanung, andererseits hat Qualität aber auch etwas mit Sichtweisen, Werten, Wissen, Handlungskompetenzen und Ressourcen zu tun.

Krohinkel sieht Qualitätsentwicklung im Zusammenhang mit fördernder Prozesspflege zunächst vorrangig in der **Sicherung und Entwicklung von Kontinuität**: »Denn, Kontinuität ist das organisatorische Fundament auf dem Sichtbarkeit und Ganzheitlichkeit und Kongruenz (authentisch sein) im Pflegeprozess in der direkten Pflege erfasst, entwickelt, überprüft, stabilisiert und weiterentwickelt werden kann. Auch aus diesem Grund ist Bezugspersonenpflege so wesentlich. Eine entsprechende **Pflegeprozessdokumentation soll diesen Prozess und seine Wirkung stützen, sichtbar und nachweisbar machen**.

Die übergeordnete Zielsetzung der Fördernden Prozesspflege, das heißt der pflegerische Beitrag zur Gesundheit in unterschiedlichen Phasen des Lebensprozesses, ist es, betroffene Menschen zu unterstützen und zu fördern beim Erhalten, Erlangen und Wiedererlangen der Anteile von Unabhängigkeit und Wohlbefinden in den ABEDL®, welche für diese Menschen bedeutend und möglich sind.«

Das „Modell zum reflektierenden Erfahrungslernen“

In das Qualitätsentwicklungsmodell integriert ist das »*Modell zum reflektierenden Erfahrungslernen*«. **Die Anwendung des Pflegeprozesses (Regelkreis) führt zum Erfahrungslernen und zu einem neuen (veränderten) Problembewusstsein**. Krohwinkel versteht unter »fördernder Prozesspflege« die Anwendung der Schritte/Phasen des Pflegeprozesses im Sinne eines Regelkreises, bei dem es zum »Erfahrungslernen« kommt:

- **Ausgangspunkt** ist die **Praxiserfahrung** der Pflegenden bzw. die konkrete Pflegesituation.
- Im nächsten Schritt werden die **eigene Praxis reflektiert** und die im Pflegeprozess gemachten neuen **Erfahrungen**/gesammelten Erkenntnisse **erfasst** und **evaluiert** (Erfahrungsprozess).
- Das führt häufig zu einem **neuen Problembewusstsein**. Es werden ggf. neue Problemlösungen erarbeitet, die in der Praxis (aktiv) erprobt, **wieder reflektiert** und die im Pflegeprozess gemachten neuen Erfahrungen/gesammelten Erkenntnisse **erfasst** und **evaluiert** (Erfahrungsprozess).
- Diese neue Praxiserfahrung ist dann wieder der Ausgangspunkt für weitere konkrete Pflegesituationen. Diese **Verknüpfung von Erfahrungen und Theorie führt dauerhaft zu einem veränderten Pflegeverständnis und zu neuen Pflegekonzepten**. Gelingt es, das Konzept von Krohwinkel umzusetzen, kann eine an den Bedürfnissen der Hilfe- und Pflegebedürftigen orientierte und fördernde Prozesspflege in der Praxis entstehen.

Pflegediagnosen und Klassifikationssysteme

(siehe separate Datei - **Pflegediagnosen**)

Informationen sammeln (in andere Datei setzen !!!)

Die Sammlung pflegerelevanter Informationen bestimmt entscheidend die Qualität der pflegerischen Dienstleistung, die mithilfe des Pflegeprozesses erreicht werden soll.

Als mögliche Informationsquellen stehen eine Reihe von **Personen** oder **Dokumenten** zur Verfügung:

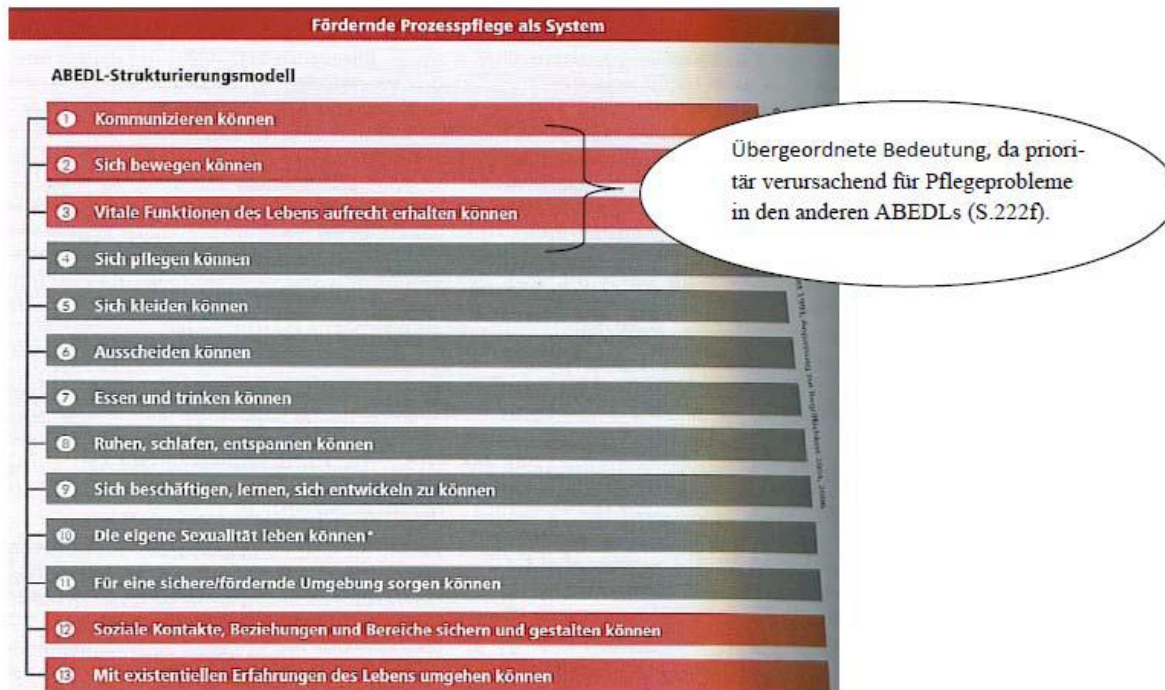
- Patient oder **Bewohner** sowie **Angehörige** und andere **Bezugspersonen**
- Andere Pflegende, z. B. in **zuweisenden Einrichtungen**
- Andere Berufsgruppen, z. B. **Ärzte, Physiotherapeuten**, Seelsorger
- Unterlagen, z. B. **Patientenakte, Arztbriefe, Befunde**
- Einweisungsschein oder **Pflegeverlegungsbericht**
- Pflegebericht und andere Teile des Dokumentationssystems (➤ 6.4.3 , ➤ Abb. 7.2).

Stammdaten und Erstgespräch

(siehe separate Datei)

Biografiebogen

(siehe separate Datei)



Die 13. ABEDL hat einen Einfluss auf alle anderen ABEDLs!!!

Die ABEDL „**Kommunizieren zu können**“, „**sich bewegen können**“ und „**vitale Funktionen aufrecht erhalten zu können**“ werden fokussiert, da sie häufig prioritär verursachend sind für Pflegeprobleme auch in den anderen ABEDLs

